Institut Català de la Salut

# CONVOCATÒRIA

## Diplomat/ada sanitari/ària en infermeria

## (DSI.LLIURE-2018)

# Model A

## Primera prova
## Primer exercici (test)

**Es contesta en el "Full de l'examen" en les respostes de l'1 a la 76.**

**Data: 12 de maig de 2019**

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

# CONVOCATÒRIA

(proves selectives per a places de personal laboral)

(DEL 11 JUNE 2018)

Model A

**1 ) En relació amb l'atenció primària orientada a la comunitat, quina de les accions següents és INCORRECTA?**

a ) Conèixer la comunitat i detectar les seves necessitats.

b ) Prioritzar l'àmbit a abordar i les intervencions.

c ) Conèixer les necessitats de l'equip d'atenció primària per plantejar-les a la comunitat.

d ) Conèixer amb suficient detall els aspectes epidemiològics del problema sobre el qual es pretén actuar.

**2 ) En referència a l'Institut Català de la Salut: " Ser l'organització de referència i líder en el sistema de salut català, tant en l'assistència com en la docència i la investigació", ÉS:**

a ) Missió

b ) Imatge corporativa

c ) Objectiu corporatiu

d ) Visió

**3 ) La incapacitat de coordinar els moviments musculars es denomina:**

a ) Agnòsia

b ) Afàsia

c ) Apràxia

d ) Atàxia

**4 ) La xerostomia és un símptoma freqüent en la persona amb malaltia en fase terminal. Quina de les recomanacions següents és INCORRECTA?**

a ) Netejar la boca amb raspall suau.

b ) Hidratació parenteral.

c ) Mastegar pinya.

d ) Mantenir la mucosa i llavis humits.

**5 ) Davant d'una reacció transfusional, quina de les actuacions següents és INCORRECTA?**

a ) Disminuir la velocitat de la infusió.

b ) Mantenir la via endovenosa.

c ) Avaluar l'estat respiratori de la persona.

d ) Controlar els signes vitals i comparar-los amb els basals.

**6 ) Quin dels analgèsics següents està inclòs en el segon esglaó de l'escala analgèsica de la Organització Mundial de la Salut?**

a ) Paracetamol

b ) Àcid Acetilsalicílic

c ) Codeïna

d ) Morfina

**7 ) Les varius esofàgiques es desenvolupen en la majoria de persones diagnosticades de cirrosi hepàtica. Quin és el mecanisme fisiològic que les provoca?**

a ) Venotrombosi hepàtica

b ) Anomalies congènites vasculars de la vena esplènica

c ) Vasculopatia perifèrica

d ) Hipertensió portal

**8 ) En el procés infermer, la informació recollida sobre l'estat de salut d'una persona correspon a:**

a ) El diagnòstic

b ) La planificació

c ) L'execució

d ) La valoració

**9 ) En relació amb les consideracions especials en l'administració de la nutrició parenteral a les persones amb trastorns digestius, és FALS que cal:**

a ) Comprovar el residu gàstric, especialment quan s'inicia la nutrició i en persones amb risc d'aspiració.

b ) Iniciar la perfusió augmentant progressivament el volum i la concentració, a fi de donar temps al sistema vascular i al pàncrees per adaptar-se.

c ) Mantenir en tot moment una tècnica estèril.

d ) Comprovar la permeabilitat de la via d'administració.

**10 ) En la valoració d'una persona amb Alzheimer avançat, quina eina utilitzaries per mesurar el nivell de sobrecàrrega del cuidador principal?**

a ) Test de Pfeiffer

b ) Escala de Barthel

c ) Test de Zarit

d ) Escala de Gijón

**11 ) Quina de les següents ÉS causa desencadenant de la insuficiència renal aguda de tipus postrenal?**

a ) Hipovolèmia

b ) Obstrucció del tracte urinari

c ) Isquèmia renal

d ) Glomerulonefritis aguda

**12 ) En relació amb la neutropènia, NO és cert que:**

a ) La febre és un signe sempre present.

b ) La disminució de neutròfils és menor de 2.000/mm3.

c ) El risc d'infecció és alt.

d ) Una causa és l'anèmia aplàstica.

**13 ) Si l'objectiu d'un estudi és conèixer l'experiència viscuda per les famílies d'infants ingressats a oncologia, quin ÉS el disseny més adequat?**

a ) Disseny d'assaig clínic aleatoritzat i controlat

b ) Disseny observacional

c ) Disseny qualitatiu fenomenològic

d ) Disseny qualitatiu etnogràfic

**14 ) Quina de les següents afirmacions sobre les maniobres de reanimació cardiopulmonar en el suport vital bàsic en adults és FALSA?**

a ) Fer les compressions toràciques amb una freqüència de 100 a 120 per minut.

b ) Comprimir amb una profunditat aproximada de 5 cm, però no més de 6 cm.

c ) La relació compressions/ventilacions és de 15:2.

d ) La interrupció màxima de les compressions toràciques per donar dues ventilacions no hauria de superar els 10 segons.

**15 ) Respecte a la vacunació antidiftèria, antitetànica i antipertússica acel·lular (DTPa) en les dones embarassades, és CORRECTE que:**

a ) Es recomana de forma sistemàtica la vacunació en les dones embarassades abans de la setmana 27 de gestació de cada embaràs.

b ) Es recomana de forma sistemàtica la vacunació en les dones embarassades entre la setmana 27 i 36 de gestació de cada embaràs.

c ) Si la dona embarassada està correctament vacunada del tètanus, no és necessària una nova administració en cada embaràs.

d ) No està recomanada durant l'embaràs.

**16 ) La persona que atens et transmet una informació confidencial, fins quant de temps mantindràs aquesta confidencialitat?**

a ) No és necessari mantenir la confidencialitat fora de l'àmbit professional.

b ) Més enllà de l'acabament del procés assistencial.

c ) A l'acabament del procés assistencial.

d ) Fins a la mort de la persona atesa.

**17 ) Quina de les següents afirmacions relacionades amb l'ús d'analgèsics en les cures pal·liatives és FALSA?**

a ) Es poden combinar analgèsics perifèrics amb analgèsics centrals.

b ) Sempre que sigui possible, cal utilitzar la via oral.

c ) Fer ús del placebo.

d ) La potència de l'analgèsic la determinarà la intensitat del dolor.

**18 ) El cribratge de les complicacions en la diabetis mellitus tipus 2 NO inclou:**

a ) Cribratge per a la detecció de la fenilcetonúria

b ) Cribratge per a la detecció de la retinopatia

c ) Cribratge per a la detecció de la nefropatia

d ) Cribratge per a la detecció de neuropatia

**19 ) Davant d'una persona amb sospita d'infecció evident, hipotensió, taquicàrdia, taquipnea, hipertèrmia i confusió mental, cal pensar en un estat de:**

a ) Xoc sèptic

b ) Xoc cardiogènic

c ) Xoc hipovolèmic

d ) Xoc neurogen

**20 ) En referència a la reacció d'anafilaxi, quina opció és FALSA?**

a ) És una reacció sistèmica d'hipersensibilitat després de l'exposició a certes substàncies.

b ) A nivell cutani es manifesta eritema i angioedema.

c ) És sinònim de xoc anafilàctic.

d ) Pot produir un broncoespasme.

**21 ) Amb quina freqüència cal fer el cribratge de la hipertensió arterial a una persona de 52 anys que no presenta cap factor de risc?**

a ) Cada 4 anys

b ) Cada 2 anys

c ) Cada 3 anys

d ) Cada any

**22 ) Segons el Protocol d'activitats preventives i de promoció de la salut a l'edat pediàtrica, quantes peces dentals ha de tenir un infant de 8 anys segons el calendari de dentició?**

a ) 18

b ) 20

c ) 22

d ) 24

**23 ) Les precaucions estàndard són l'estratègia bàsica per fer front a la transmissió d'agents infecciosos en els centres sanitaris. De les següents afirmacions, quina és la CORRECTA?**

a ) S'han d'aplicar només a aquelles persones en què hi ha una sospita o confirmació d'una infecció.

b ) S'apliquen quan hi pugui haver contacte amb qualsevol fluid corporal, incloent-hi la suor.

c ) Inclouen les mesures d'higiene respiratòria.

d ) Es basen en el principi que la pell intacta i les membranes mucoses poden contenir i transmetre agents infecciosos.

**24 ) Un dels beneficis de l'oxigenoteràpia contínua domiciliària ÉS:**

a ) La prevenció de la hipertensió pulmonar

b ) L'augment de la policitèmia

c ) La disminució del pes corporal

d ) La millora de la hidratació de la mucosa nasal

**25 ) La disúria es defineix com**

a ) L'augment de la quantitat d'orina relacionat amb un augment de la ingesta de líquids.

b ) La disminució de la quantitat d'orina emesa.

c ) La necessitat d'orinar durant la nit.

d ) El dolor o coïssor durant la micció, degut generalment a una infecció del tracte urinari.

**26 ) En relació amb el tractament amb acenocumarol, quina de les recomanacions següents és FALSA?**

a ) El consum d'alcohol dificulta el control del tractament.

b ) El consum de grans quantitats de mango pot augmentar la ràtio internacional normalitzada (INR).

c ) Els fibrats són inhibidors de la ràtio internacional normalitzada (INR).

d ) L'ibuprofèn és un dels fàrmacs antiinflamatoris que no interfereixen de manera rellevant en el control de la ràtio internacional normalitzada (INR).

**27 ) Respecte al procediment de la prova de la tuberculina en adults, assenyala la resposta FALSA:**

a ) El vial es pot mantenir un mes obert si està dins de la data de caducitat.

b ) Es pot practicar a les dones embarassades.

c ) Cal injectar lentament 0,2 ml per via intradèrmica

d ) La lectura es farà a les 48-72 hores.

**28 ) En el cas que rebis alguna indicació d'un altre professional de l'equip de salut que consideres que pot causar un dany a la persona atesa, quina NO serà la teva actuació?**

a ) Procuraràs que no es dugui a terme.

b ) T'abstindràs de participar-hi.

c ) Ho portaràs a terme i deixaràs constància escrita a la història clínica.

d ) Informaràs de la teva decisió a l'autoritat o persona que correspongui

**29 ) El reforçament dels músculs del sòl pelvià ÉS el tractament de rehabilitació d'elecció en la:**

a ) Incontinència urinària d'esforç

b ) Incontinència urinària per sobreeiximent

c ) Incontinència urinària funcional

d ) Incontinència fecal

**30 ) En un pacient amb una hemorràgia subaracnoidal, quina de les següents intervencions per prevenir l'augment de la pressió intracranial és FALSA?**

a ) Mantenir el capçal del llit elevat a 90º.

b ) Evitar la rotació i la flexió del coll.

c ) Prevenir el restrenyiment.

d ) Minimitzar els estímuls ambientals.

**31 ) Un adult en tractament amb anticoagulants orals (TAO) i dins del rang terapèutic acudeix per vacunació. La fitxa tècnica de la vacuna indica que s'ha d'administrar per via intramuscular. Quina seria l'actuació CORRECTA?**

a ) Administrar la vacuna per via subcutània, ja que pren TAO.

b ) Seguir les indicacions de la fitxa tècnica i les recomanacions per evitar la presència d'hematomes.

c ) A les persones amb TAO està contraindicada l'administració de vacunes.

d ) L'eficàcia i reactogenicitat de la vacuna no està relacionada amb la via d'administració.

**32 ) El tipus de respiració que es caracteritza per cicles regulars en què s'incrementa la freqüència i la profunditat de la respiració i que després decreixen fins a l'apnea es donimina:**

a ) Hiperpnea

b ) Respiració de Biot

c ) Respiració de Cheyne-Stokes

d ) Respiració de Kussmaul

**33 ) Atens una persona a urgències que presenta una disminució del nivell de consciència després de prendre diversos comprimits de diazepam. Quin ÉS l'antídot de la intoxicació per benzodiazepines?**

a ) Naloxona

b ) Flumazenil

c ) Neostigmina

d ) Piridoxina

**34 ) Davant d'un adult amb virus de l'hepatitis C (VHC), els professionals sanitaris han d'adoptar una sèrie de precaucions. Quina de les mesures següents NO és necessària?**

a ) Rentar-se les mans abans i després del contacte amb el pacient.

b ) Posar-se una mascareta quirúrgica per visitar-lo.

c ) Utilitzar guants si se li fa una extracció de sang.

d ) Notificar qualsevol lesió accidental amb material potencialment contaminant.

**35 ) Quina de les recomanacions següents NO correspon a l'alta en una intervenció quirúrgica de l'orella mitjana?**

a ) Evitar mocar-se durant 2-3 setmanes.

b ) Tossir amb la boca oberta.

c ) És normal la pèrdua auditiva durant un temps.

d ) És normal la secreció purulenta de l'orella.

**36 ) En referència als residus sense risc o inespecífics generats en un centre sanitari, assenyala quin d'aquests pertany al grup II:**

a ) Cartró

b ) Matèria orgànica

c ) Bosses buides d'orina

d ) Agulles

**37 ) Estàs oferint estratègies per promoure la continència urinària. Quina de les estratègies següents és FALSA?**

a ) Deixar de fumar.

b ) Restricció d'ingesta de líquids.

c ) Orinar regularment de cinc a vuit cops al dia.

d ) Evitar irritants vesicals com ara cafeïna i alcohol.

**38 ) Els símptomes greus d'ansietat després d'experimentar un esdeveniment traumàtic es denomina:**

a ) Trastorn d'estrès posttraumàtic

b ) Trastorn mental

c ) Trastorn depressiu

d ) Trastorn obsessiu-compulsiu

**39 ) La mesura de la circumferència abdominal ens aporta informació sobre el risc cardiovascular (RCV) que té una persona. A partir de quina xifra s'estableix el valor màxim saludable del perímetre abdominal en l'RCV?**

a ) 102 cm en homes i 80 cm en dones

b ) 102 cm en homes i 88 cm en dones

c ) 110 cm en homes i 90 cm en dones

d ) 95 cm en homes i 80 cm en dones

**40 ) En relació amb la prevenció terciària en el tractament de l'asma infantil, quina de les afirmacions següents és CERTA:**

a ) És la prevenció que es realitza abans de l'exposició a factors de risc en individus susceptibles, per intentar prevenir l'inici de l'asma.

b ) És la prevenció del desenvolupament de malaltia persistent en persones susceptibles que ja han presentat sensibilització a l'al•lergogen.

c ) Són les estratègies de prevenció dirigides a evitar la sensibilització al•lèrgica en el període prenatal i perinatal.

d ) És la prevenció d'aguditzacions, evitant l'exposició a factors desencadenants o irritants mediambientals una vegada ja instaurada la malaltia.

**41 ) Quant a les recomanacions per a la desinfecció i esterilització dels materials sanitaris, en relació amb els factors que afecten l'efectivitat dels desinfectants químics, quina d'aquestes afirmacions és CERTA?**

a ) Els desinfectants s'activen en presència de matèria orgànica.

b ) Els dispositius s'han d'assecar abans de submergir-los en desinfectant.

c ) Les característiques del material i dels dispositius no afecten la qualitat de la neteja.

d ) La durada i temperatura d'exposició al desinfectant és indiferent per a la seva efectivitat.

**42 ) Respecte a les secrecions pancreàtiques que intervenen en el procés de digestió, quina d'aquestes afirmacions és FALSA?**

a ) La lipasa és un enzim que participa en la digestió dels greixos.

b ) Les secrecions pancreàtiques tenen un pH àcid.

c ) La tripsina és un enzim que participa en la digestió de les proteïnes.

d ) Les secrecions intestinals totalitzen prop d'un litre al dia de suc pancreàtic.

**43 ) En relació amb les complicacions potencials secundàries a la nutrició enteral, és FALS que la diarrea està relacionada amb:**

a ) Administració ràpida de la fórmula

b ) Administració a temperatura alta

c ) Contaminació bacteriana de la dieta

d ) Dieta baixa en residus

**44 ) En relació amb la pericarditis, és FALS que:**

a ) El símptoma més característic és el dolor toràcic.

b ) La causa és sempre una infecció bacteriana.

c ) El tamponament cardíac n'és una complicació freqüent.

d ) De vegades és asimptomàtica.

**45 ) Quant al tipus de sonda en el procediment de sondatge vesical, és FALS que:**

a ) La sonda vesical de làtex té una elevada fixació bacteriana.

b ) La sonda vesical de silicona s'utilitza en sondatges amb una duració inferior a 15-20 dies.

c ) La sonda vesical de làtex pot mantenir-se fins a 45 dies.

d ) La sonda Nelaton està indicada en la recollida de mostres.

**46 ) Quin dels símptomes o signes següents NO és propi de la hipocalcèmia?**

a ) Convulsions

b ) Signe de Chvostek

c ) Polidípsia

d ) Rampes musculars

**47 ) En un estudi amb l'objectiu d'estimar la prevalença de maltractament en una població escolaritzada, quin disseny ÉS l'adequat?**

a ) Disseny d'assaig clínic aleatoritzat i controlat

b ) Disseny de correlació ecològica

c ) Disseny observacional, descriptiu i longitudinal

d ) Disseny observacional, descriptiu i transversal

**48 ) Quan es respecta la voluntat i la presa de decisions de la persona atesa amb competència per comprendre i decidir, quin valor professional s'hi està aplicant segons el Codi d'ètica de les infermeres i infermers?**

a ) Responsabilitat

b ) Autonomia

c ) Intimitat i confidencialitat

d ) Justícia social

**49 ) Quin ÉS l'interval recomanat d'infusió d'una unitat de plaquetes (260-320 ml) en adults sense afectació hemodinàmica i amb pes estàndard?**

a ) 90-120 minuts

b ) 10-20 minuts

c ) 30-60 minuts

d ) 2-4 hores

**50 ) La taula de Llevant ÉS un instrument que permet:**

a ) Detectar precoçment una desviació possible en el desenvolupament psicomotor de l'infant de menys de dos anys i mig.

b ) Proporcionar un diagnòstic sindròmic de l'infant de menys de dos anys i mig.

c ) Proporcionar un diagnòstic etiològic de l'infant de menys de dos anys i mig.

d ) Proporcionar un diagnòstic funcional de l'infant de menys de dos anys i mig.

**51 ) Quina de les següents ÉS una estratègia d'afrontament no adaptativa davant d'una situació de malaltia?**

a ) Fer activitats d'oci.

b ) L'expressió emocional dels sentiments.

c ) Relaxar-se.

d ) Autoculpabilitzar-se.

**52 ) En relació a la prevenció de l'atelèctasi en un ancià enllitat quina de les següents respostes és FALSA:**

a ) Realitzar canvis posturals freqüents.

b ) Mobilització precoç del llit a cadira.

c ) Utilització de l'espirometria d'incentiu.

d ) Recomanar respiracions superficials.

**53 ) En el dolor lumbar agut, una de les mesures no farmacològiques efectives ÉS:**

a ) Estar actiu.

b ) Suports lumbars.

c ) Repòs en el llit.

d ) Dormir de bocaterrosa.

**54 ) Quin dels controls clínics següents NO s'efectua a una dona durant el puerperi hospitalari?**

a ) Control de la involució uterina

b ) Valoració dels loquis

c ) Valoració de l'estat emocional

d ) Control de la dinàmica uterina

**55 ) Quina de les recomanacions següents NO correspon a la cura de l'estomatitis lleu?**

a ) Aplicar-hi lubricant labial hidrosoluble.

b ) Higiene bucal amb solució salina.

c ) Evitar aliments molt condimentats

d ) Ús de solucions bucals amb alcohol.

**56 ) Respecte al procediment de la sonda de gastrostomia endoscòpica percutània (PEG), assenyala la resposta CORRECTA:**

a ) Cal girar cada dia la sonda 180° en el sentit de les agulles del rellotge.

b ) En col•locar la sonda, cal introduir-la en angle de 30° respecte a l'abdomen de la persona.

c ) Si hi ha supuració a nivell de l'orifici d'entrada de la sonda, cal retirar-la.

d ) En finalitzar l'administració de l'alimentació per la PEG, cal posar la persona en decúbit supí immediatament.

**57 ) Quina de les indicacions següents NO correspon a les que s'han de seguir per tal d'evitar la transmissió de l'agent biològic per via parenteral?**

a ) Encaputxar les agulles després del seu ús per evitar punxades accidentals d'altres professionals.

b ) Llençar aquests tipus de material en els contenidors de residus grup III que hauran d'estar en llocs accessibles (al costat del lloc on es fa la tècnica) i no omplir-los més del 75% de la seva capacitat.

c ) La persona que utilitza el material tallant o punxant ha de llençar-lo personalment per evitar accidents a d'altres persones.

d ) Utilitzar, sempre que se'n disposi, materials amb sistemes que evitin les exposicions accidentals (sistemes sense agulla, agulles de sutura roma, agulles de seguretat).

**58 ) Quina de les escales següents utilitzaries per valorar la funció familiar?**

a ) Test d'APGAR familiar

b ) Escala de Barthel

c ) Escala de Braden

d ) Escala de Gijón

**59 ) En la dieta d'una persona amb diabetis mellitus tipus 2, els greixos:**

a ) Han d'aportar el 20-30% del total calòric diari.

b ) Han d'aportar el 40-50% del total calòric diari

c ) Han d'aportar el 10-15% del total calòric diari.

d ) El seu consum és lliure.

**60 ) Segons el model de Patricia Benner, la infermera amb un domini intuïtiu de la situació i que és capaç d'identificar l'origen del problema, es troba en el nivell de:**

a ) Experta

b ) Principiant avançada

c ) Competent

d ) Eficient

**61 ) Quina de les següents NO és una estratègia terapèutica del xoc hipovolèmic?**

a ) Fàrmacs vasoactius.

b ) Suport ventilatori.

c ) Revertir la causa primària de la hipovolèmia

d ) Restricció de líquids.

**62 ) Quina de les modificacions de l'estil de vida NO és de major eficàcia per reduir la pressió arterial?**

a ) Perdre, com a mínim, 4 kg de pes si l'IMC és > o igual a 27.

b ) Fer activitat física regular aeròbica i isotònica.

c ) Reduir la ingesta d'alcohol en persones bevedores.

d ) Mantenir una ingesta de sal de 8 g/dia.

**63 ) Indica l'afirmació CORRECTA en relació amb l'escala analgèsica de l'Organització Mundial de la Salut (OMS):**

a ) Quan una persona porta molt de temps en un esglaó, tot i que el tractament estigui sent efectiu, cal plantejar-se el canvi a l'esglaó següent.

b ) L'escala analgèsica de l'OMS equival a l'escala visual analògica (EVA)

c ) Els analgèsics del tercer esglaó es poden associar amb els del primer esglaó.

d ) Podem fer servir a la vegada opioides dèbils i opioides potents.

**64 ) En relació a les sutures adhesives es CERT que:**

a ) Estan indicades en zones amb tensió.

b ) Estan indicades en ferides en què no es pugui parar l'hemorràgia o secrecions.

c ) Estan contraindicades en pacients grans amb pell fina o fràgil.

d ) Estan indicades en ferides amb alt potencial d'infecció.

**65 ) Quina de les següents afirmacions respecte a la mesura de la pressió venosa central (PVC) és INCORRECTA?**

a ) Fer la mesura amb la persona en decúbit supí.

b ) La punta del catèter venós central ha d'estar allotjada a l'aurícula dreta o vena cava superior.

c ) S'ha d'ajustar el punt 0 de la columna d'aigua al quart espai intercostal de la línia mitjana axil•lar.

d ) La tos no interfereix en la mesura de la PVC.

**66 ) Acudeix al servei d'urgències una persona amb hipotensió, bradicàrdia i miosi bilateral, cal pensar en:**

a ) Reacció anafilàctica

b ) Sobredosi per opiacis

c ) Sobredosi per cocaïna

d ) Infart agut de miocardi

**67 ) Amb l'exploració simple de l'agudesa visual en un infant, mitjançant les escales d'optotips a un mínim de cinc metres, es poden diagnosticar:**

a ) Miopies

b ) Hipermetropies

c ) Astigmatismes

d ) Anomalies de les parpelles

**68 ) Quina de les següents informacions sobre el tractament farmacològic per a la diabetis mellitus tipus 2 és FALSA?**

a ) A l'inici del tractament amb metformina poden aparèixer trastorns gastrointestinals.

b ) Els inhibidors de la dipeptidil peptidasa 4 (iDPP-4) es poden administrar amb o sense aliments.

c ) Les glinides s'han de prendre després dels àpats principals.

d ) Les sulfonilurees incrementen el risc d'hipoglucèmia.

**69 ) L'alimentació és un determinant fonamental de l'estat de salut de les persones. Quin d'aquests consells és INCORRECTE?**

a ) En l'edat avançada, les cremes de fruita seca o la fruita seca triturada són una bona opció per vèncer les dificultats de masticació i per enriquir nutricionalment les preparacions.

b ) Qualsevol persona, sobretot si pateix hipertensió o algun trastorn cardiovascular, es beneficia de reduir el consum de sal.

c ) L'aportació calòrica de l'oli d'oliva verge és menor que la d'altres olis vegetals com el gira-sol i el blat de moro.

d ) El consum de cereals integrals, en lloc de refinats, es relaciona amb menys risc de mortalitat en general, i de càncer colorectal i malalties cardiovasculars en particular.

**70 ) Entre les cures relacionades amb l'alimentació per sonda nasogàstrica NO es troba:**

a ) Control del pes

b ) Control del volum residual abans de cada presa

c ) Valoració dels signes de deshidratació

d ) Administració de l'alimentació en decúbit supí

**71 ) El Pla de Salut de Catalunya contempla, com a principi inspirador, planificar les seves actuacions des d'un vessant:**

a ) Predictiu, preventiu i proactiu

b ) Preventiu, holístic i protector

c ) Pràctic, preventiu i protector

d ) Proactiu, pràctic i preventiu

**72 ) Una persona adulta presenta una obstrucció de la via aèria per un cos estrany mentre dinava. Després de diversos intents fallits per resoldre l'obstrucció, l'home perd la consciència. Quina acció s'ha de realitzar immediatament?**

a ) Animar-lo a tossir.

b ) Donar 5 cops a l'esquena.

c ) Fer 5 compressions abdominals.

d ) Iniciar maniobres de reanimació cardiopulmonar amb compressions toràciques.

**73 ) Quina d'aquestes recomanacions alimentàries de la dieta d'infants de zero a tres anys és FALSA?**

a ) Cal evitar els espinacs i les bledes abans dels dotze mesos (i si se'n donen, que no suposin més del 20% del contingut total del plat).

b ) Es poden oferir petites quantitats de iogurt i formatge tendre a partir dels nou o deu mesos.

c ) Pel seu contingut en mercuri, en infants menors de tres anys cal evitar el consum de salmó, orada i llobarro.

d ) Es recomana evitar la mel en infants més petits de dotze mesos pel risc d'intoxicació alimentària per botulisme.

**74 ) Quina de les següents són característiques que corresponen a una lesió per pressió d'estadi III?**

a ) Necrosi tissular i afectació del teixit muscular.

b ) Eritema amb pell intacta que no es blanqueja amb la pressió.

c ) Cràter profund, amb lleuger exsudat i amb marges ben definits.

d ) Presenta erosió i flictenes.

**75 ) En quina de les zones següents administraries una vacuna intramuscular a un infant de 6 mesos?**

a ) Múscul vast lateral

b ) Múscul deltoide

c ) Múscul gluti major

d ) Múscul gluti mitjà

**76 ) De les afirmacions següents, quina defineix l'entrevista motivacional?**

a ) Utilitza la discussió i l'autoritat per provocar el canvi de comportament.

b ) El seu objectiu és proporcionar recomanacions i consells.

c ) Està centrada en la família per facilitar un canvi de comportament.

d ) Està centrada en la persona per facilitar un canvi de comportament.

Institut Català
de la Salut

# CONVOCATÒRIA

## Diplomat/ada sanitari/ària en infermeria

## (DSI.LLIURE-2018)

# Model A

## Primera prova
## Segon exercici (supòsits pràctics)

Es contesta en el "Full de l'examen" en les respostes de la 101 a la 124.

**Data: 12 de maig de 2019**

**Supòsit pràctic 1**

La Sra. Fina té 83 anys i viu sola. Arriba a urgències de l'hospital acompanyada per la seva filla per caiguda casual a domicili. Té antecedents d'hipertensió arterial, arrítmia cardíaca per fibril·lació auricular coneguda des dels 68 anys i osteoporosi.
No presenta al·lèrgies ni hàbits tòxics coneguts i està en tractament amb enalapril 20 mg 1 compr./dia, paracetamol 1 g 3 compr./dia i acenocumarol (segons pauta). No té antecedents de caigudes prèvies el darrer any.
A la valoració inicial s'evidencia: pressió arterial (PA): 145/90 mmHg; freqüència cardíaca (FC): 90 pulsacions per minut, pols arrítmic; freqüència respiratòria (FR): 18 respiracions per minut; $SatO_2$: 96%; índex de massa corporal (IMC): 26; escala EVA de dolor: 7. Presenta impotència funcional, extremitat inferior dreta escurçada i en rotació externa amb presència d'hematoma. Se li fa una anàlisi de sang i radiografia. L'exploració radiològica confirma una fractura subcapital de fèmur dret. Es decideix el seu ingrés per a control i intervenció quirúrgica.

101. L'IMC de la Sra. Fina correspon a:
   a) Normopès
   b) Sobrepès
   c) Obesitat
   d) Obesitat mòrbida

102. En aquest cas, quins dels factors següents NO s'associa a risc elevat de fractura per fragilitat?
   a) Consum de tabac
   b) Caigudes en el últim any
   c) Ús perllongat de tractament amb glucocorticoide
   d) Índex de massa corporal superior a 20 $kg/m^2$

103. En el cas de la Sra. Fina, quan valores la circulació, el moviment i la sensibilitat de l'extremitat, n'estàs valorant:
   a) L'estat mental
   b) L'estat neuromuscular
   c) L'estat neurovascular
   d) L'estat de la funció articular

A les 28 hores de l'ingrés es fa la intervenció quirúrgica de reemplaçament total de maluc.

104. En una intervenció de reemplaçament total de maluc, quina d'aquestes és la posició CORRECTA de l'articulació del maluc per evitar una luxació de la pròtesi?
   a) Pronació
   b) Abducció
   c) Tracció
   d) Adducció

En el postoperatori immediat es fa un hemograma de control, que evidencia una disminució important de l'hematòcrit, i s'indica transfusió de dos concentrats d'hematies.

105. Quin ÉS el temps màxim d'infusió en una transfusió de concentrat d'hematies?
   a) 1 hora
   b) 2 hores
   c) 4 hores
   d) 6 hores

La Sra. Fina és portadora de sonda vesical des de la intervenció quirúrgica. Els pacients d'edat avançada sovint no experimenten els símptomes típics d'infecció del tracte urinari.

106. Amb referència a aquests símptomes inespecífics més freqüents de la infecció del tracte urinari, assenyala quin és el CORRECTE.
   a) Desorientació
   b) Rampes
   c) Hipoventilació
   d) Pruïja

A l'alta, a la Sra. Fina se li prescriu de forma profilàctica heparina de baix pes molecular.

107. De les següents consideracions especials en la tècnica de l'administració subcutània d'heparina de baix pes molecular en adults, quina afirmació és INCORRECTA?
   a) El plec cutani on s'injecta i la xeringa han de formar un angle de 60º.
   b) El millor lloc per aplicar la injecció és l'àrea abdominal a uns 5-6 cm de distància del melic.
   c) Es pot injectar a les cuixes o les natges.
   d) No cal fregar la zona després d'administrar la injecció.

**Supòsit pràctic 2**

El Sr. Joan té 74 anys. Viu al seu domicili amb la seva dona de 72 anys. És fumador de 10 cigarretes/dia. Té antecedents d'hipertensió arterial (HTA) i hipercolesterolèmia. Està en tractament amb enalapril 20 mg 1compr./dia, furosemida 1 compr./dia i simvastatina 20 mg 1 compr./dia. És autònom i independent per a les activitats bàsiques i instrumentals de la vida diària.
El Sr. Joan va al centre de salut a visitar-se, ja que no es troba bé. Refereix que fa una setmana dorm a la butaca. Presenta edemes amb fòvea en extremitats inferiors i taquicàrdia >120 batecs/minut, pressió arterial (PA): 160/90 mmHg, freqüència respiratòria (FR): 24 respiracions per minut, i $SatO_2$: 94%. És diagnosticat d'insuficiència cardíaca i se li pauta tractament amb betablocadors, i s'augmenta la dosi de diürètics

108. Els criteris Framingham permeten plantejar un diagnòstic clínic de sospita d'insuficiència cardíaca. Quin dels següents ÉS un signe o símptoma major?
   a) Dispnea d'esforç
   b) Tos nocturna
   c) Edema mal·leolar
   d) Ingurgitació jugular

109. Quin NO seria un efecte freqüent o ocasional del tractament farmacològic amb betablocadors d'un pacient amb insuficiència cardiaca?
   a) Edema perifèric
   b) Augment de pes
   c) Disfunció erèctil
   d) Taquicàrdia

Per aconseguir un bon compliment terapèutic, és imprescindible que el Sr. Joan conegui tots els aspectes relacionats amb la cura de la seva malaltia; per aquest motiu, és necessari que durant la visita mantinguem una actitud d'escolta activa.

110. Quina de les habilitats següents NO facilita la escolta activa?
   a) Mantenir el contacte ocular.
   b) Expressar inicialment el propi acord o desacord.
   c) Saber estar en silenci.
   d) Manifestar comprensió.

En una visita de control repassem els consells respecte a la dieta adequada per al bon control de les seves patologies. El Sr. Joan té les xifres de pressió arterial ben controlades, té normopès, està estable i sense signes de descompensació.

111. Quin d'aquests NO seria un consell adequat en aquest moment?
   a) Fer autocontrol de pes almenys tres vegades per setmana.
   b) Restringir el consum de líquids a un litre al dia.
   c) Abandonar l'hàbit tabàquic.
   d) Fer exercici físic regular individualitzat segons la tolerància.

112. Quina d'aquestes seria una recomanació adequada respecte a la dieta per a la hipercolesterolèmia?
   a) Recomanar dieta hipocalòrica.
   b) Reduir el consum de greixos monoinsaturats.
   c) Consumir entre una i cinc racions de fruita seca per setmana.
   d) Evitar fer exercici aeròbic moderat.

El Sr. Joan sap que el consum de tabac és perjudicial per a la seva patologia i ens planteja que vol deixar de fumar. Per iniciar el seguiment i tractament de deshabituació tabàquica, és important conèixer en quina etapa del procés de canvi es troba.

113. Quin ÉS el model que descriu les etapes per les quals passa la persona abans de modificar els seus hàbits, segons Prochaska i DiClemente?
   a) Model teòric del canvi
   b) Model de l'aprenentatge social
   c) Model de creences de salut
   d) Model d'acció de salut

114. En relació amb el tractament farmacològic en el procés de deshabituació del tabac, quina afirmació és CORRECTA?
    a) Un dels efectes secundaris del tractament amb els xiclets de nicotina és la reacció dermatològica local.
    b) El tractament amb bupropió pot produir nàusees, cefalea, restrenyiment, flatulència i vòmits.
    c) Visió borrosa, retenció urinària i hiperhidrosi a les mans són efectes secundaris del tractament amb vareniclina.
    d) Els comprimits de nicotina per llepar poden produir singlot, úlceres i altres molèsties bucals.

Uns dies després rebem una trucada del Sr. Joan. La dispnea ha empitjorat i presenta augment dels edemes mal·leolars. Un cop valorat a domicili, es decideix derivar a l'hospital, on és ingressat.
Quan el Sr. Joan arriba a la unitat d'hospitalització es detecta una discrepància en la medicació que prenia a casa i la nova pauta. Hi ha una interrupció del seu tractament per a l'HTA sense cap justificació clínica.

115. En el procés de conciliació de la medicació, segons la classificació d'aquest tipus de discrepància es tracta d'una:
    a) Omissió
    b) Comissió
    c) Interacció
    d) Duplicitat

En la fase de descompensació de la seva insuficiència cardíaca, és important conèixer l'estimació del cabal cardíac.

116. El càlcul del cabal cardíac ÉS:
    a) El volum batec multiplicat per la freqüència cardíaca.
    b) El volum batec més la freqüència cardíaca.
    c) El volum batec dividit per la freqüència cardíaca.
    d) El volum batec multiplicat per la freqüència cardíaca elevat al quadrat.

Durant el seu ingrés hospitalari, i com a conseqüència del repòs, el Sr. Joan presenta un quadre de restrenyiment.

117. En relació amb el restrenyiment, ÉS cert que:
    a) La metilcel·lulosa és un agent formador de volum.
    b) L'ús crònic de laxants és beneficiós.
    c) Les femtes són sempre dures.
    d) El bisacodil és un fàrmac lubricant.

**Supòsit pràctic 3**

El Sr. Felip té 68 anys, amb antecedents d'hipertensió arterial, malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) diagnosticada fa un any i hiperuricèmia. Està en tractament amb enalapril 20 mg 1 compr./dia, budesonida inhalador 2 inhalacions/12 hores, tiotropi inhalador 18 mcg 1 inhalació/dia i al·lopurinol 100 mg 1 cop/dia. És fumador de 20 cigarretes al dia, amb un consum acumulat de 48 paquets/any.
Avui arriba a urgències i explica que fa tres dies que té tos amb expectoració fosca i li falta l'aire. Va estar refredat fa un mes, però aquesta última setmana nota que s'ofega més quan camina ràpid o fa algun esforç. Presenta pressió arterial (PA): 138/86 mmHg; freqüència cardíaca (FC): 82 pulsacions per minut; freqüència respiratòria (FR): 22 respiracions per minut; $SatO_2$: 97%; $T^a$: 38,2 ºC.

118. A la història clínica trobem una espirometria amb un resultat del volum màxim expirat en el primer segon ($FEV_1$) de 62%. Segons la classificació GOLD, en quin estadi es troba aquest pacient?
   a) Estadi I o MPOC lleu
   b) Estadi II o MPOC moderada
   c) Estadi III o MPOC greu
   d) Estadi IV o MPOC molt greu

119. Quina de les següents afirmacions sobre el tractament de la malaltia pulmonar obstructiva crònica és FALSA?
   a) Els efectes adversos més freqüents dels corticoides inhalats són la ronquera, la tos i la candidiasi orofaríngia.
   b) El salbutamol millora la tolerància a l'exercici.
   c) L'efecte advers més freqüent del tiotropi és la sequedat de boca.
   d) És recomanable l'ús d'antitussígens.

L'auscultació respiratòria presenta roncus aïllats i sibilàncies a tots dos camps pulmonars. Se li fa una gasometria arterial i una radiografia de tòrax que evidencia condensació en base pulmonar dreta compatible amb pneumònia. Es decideix el seu ingrés per a control i evolució.

120. Què ens indiquen els següents valors de la gasometria arterial del Sr. Felip?
   pH = 7,2; PaCO2 = 55 mmHg; $HCO_3^-$ = 24 mEq/L
   a) Alcalosi metabòlica
   b) Acidosi respiratòria
   c) Acidosi metabòlica
   d) Alcalosi respiratòria

121. Respecte a la pneumònia del Sr. Felip, quina de les recomanacions següents és CORRECTA?
   a) Exercicis respiratoris actius.
   b) Exercici físic intens.
   c) Disminució de la ingestió de líquids.
   d) Evitar que tussi per disminuir el dolor.

S'administra tractament nebulitzat durant la seva estada hospitalària i es pauta antibiòtic i corticoides orals amb ajustament del tractament inhalador habitual.

122. Sobre el tractament de teràpia nebulitzada en una persona adulta amb diagnòstic de malaltia pulmonar obstructiva crònica és CERT que:
   a) L'aerosol produït presenta un impacte orofaringi baix i un dipòsit pulmonar alt.
   b) Permet l'administració de més d'un fàrmac a la vegada i a dosis altes.
   c) Hi ha evidència que la teràpia nebulitzada és superior a l'administrada mitjançant els altres dispositius inhaladors en pacients capaços d'utilitzar-los correctament.
   d) Durant l'administració de la teràpia nebulitzada s'han de retirar les ulleres nasals als pacients que les porten.

Durant el seu ingrés, el Sr. Felip presenta una hiperglucèmia secundària al tractament amb corticoides.

123. La determinació de la glicèmia capil·lar per part del pacient o familiar en un moment determinat es denomina:
   a) Autocontrol
   b) Autocura
   c) Autoanàlisi
   d) Alocontrol

Abans de marxar al domicili, la infermera dona unes pautes d'educació sanitària per al tractament inhalador i consell antitabac.
Al cap d'una setmana, el Sr. Felip és citat al seu centre de salut per a control i reforç educacional de la tècnica inhalatòria i explica que vol deixar de fumar. Ha reduït el consum de tabac a 15 cigarretes al dia i demana a la seva infermera informació sobre els tractaments de deshabituació.

124. Quin test mesura el grau de dependència a la nicotina?
   a) Test de Fagerström
   b) Test de Richmond
   c) Test de Barthel
   d) Test de O'Sullivan

***RECULL dels criteris de realització dels 2 exercicis de la 1a. prova, publicats a la diligència del 12.4.2019.***

***És imprescindible marcar en el "Full de l'examen" el model d'examen (A,B,C,D)***

***1a prova (test i supòsits pràctics)***

***1r. exercici (test):***

*L'exercici consistirà en la resolució d'un qüestionari de 76 preguntes tipus test amb 4 respostes alternatives i només una de correcta.*

***2n. exercici (Supòsits pràctics):***

*L'exercici consistirà en la resolució de tres supòsits pràctics, dos supòsits tindran 7 preguntes cadascú i un supòsit tindrà 10 preguntes.*

***Criteris comuns de la 1a. prova (test + supòsits pràctics):***

*Les preguntes no contestades i les contestades erròniament no tindran cap valor.*

*El temps de realització de la primera prova, que inclou els dos exercicis, serà de 2 hores. Les persones aspirants es podran distribuir aquest temps lliurement per a realitzar els 2 exercicis (test i supòsits pràctics).*

*En finalitzar els dos exercicis de la 1a. prova les persones aspirants lliuraran al responsable de l'aula el "Full de l'examen" emplenat i el full amb les etiquetes de codi de barres identificatives, i abandonaran l'aula.*

***Instruccions per emplenar el "Full de l'examen"***

*Per a la realització de la 1a. prova, els aspirants disposaran d'un "Full de l'examen" (full de lectura òptica) on hauran de resoldre les preguntes tant del test com les preguntes dels supòsits pràctics.*

- *Les preguntes del test s'hauran de respondre des de la casella núm. 1 a la casella núm. 76 del "Full de l'examen".*
- *Les preguntes dels supòsits pràctics s'hauran de respondre des de la casella núm. 101 a la casella núm. 124 del "Full de l'examen".*

*El tribunal qualificador NO corregirà els "Full de l'examen" on:*

- *No estigui marcada la casella corresponent al **model d'examen (A,B,C,D).***

*Les persones aspirants s'hauran d'ajustar a les instruccions per emplenar el "Full de l'examen" que figuren en la diligència i que se'ls doni a l'aula.*

*Les persones aspirants hauran d'emplenar la totalitat de la casella que correspongui a la resposta que considerin correcta. Les respostes marcades a la casella "E" del "Full de l'examen" es consideraran com a no contestades.*

*El tribunal no corregirà aquells exercicis que no estiguin emplenats d'acord amb les instruccions esmentades i les que es donin a l'aula.*

*Els telèfons mòbils o qualsevol altre dispositiu electrònic caldrà desconnectar-los (**dispositius totalment apagats i amb les possibles alarmes desactivades**) abans d'accedir a l'aula, i en cap moment i sota cap circumstància es podran connectar dins de l'aula.*

**L'incompliment d'aquestes normes suposarà l'anul·lació immediata de l'examen.**